

PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA

Jésica Rodríguez Álvarez, Javier Sánchez Palacios, Ana Belén Vega López, Maria Soledad Medina Martos.

INTRODUCCIÓN

La parálisis facial periférica es un cuadro frecuente de causas multifactoriales, por lo general es de causa benigna. El VII par craneal es un nervio mixto, con fibras motoras (músculos hemicara, platisma, vientre posterior del digástrico y estilohioideo), fibras sensitivas (área de Ramsey-Hunt), fibras vegetativas viscerales (gl. nasales, lacrimales, submaxilar y sublingual) y fibras sensoriales (sensibilidad gustativa 2/3 anteriores de la hemilengua homolateral).

Clasificación según localización:

- **Parálisis facial central:** se trata de una parálisis de la hemicara inferior contralateral (queda excluida musculatura frontal)
- **Parálisis facial periférica:** es una parálisis completa de toda la cara homolateral. Dentro de ésta se puede clasificar a su vez en idiopática o de Bell (70%), traumática (2º causa más frecuente), tumoral.

<u>Parálisis facial periférica</u>	<u>Parálisis facial central</u>
• Asimetría facial • Incapaz de elevar la ceja y cerrar el ojo • Signo o fenómeno de Bell presente • Desviación de la comisura bucal hacia el lado sano	• Función conservada de los músculos de la frente y párpado superior • Signo o fenómeno de Bell ausente • Generalmente presenta parálisis ipsilateral

Sospecha de parálisis facial no idiopática

- Que se produzca de forma gradual (semanas o meses)
- Afectación bilateral
- Episodios recurrentes.

DIAGNÓSTICO

Clínico

Importante realizar una buena anamnesis y una buena exploración física.

- **Anamnesis** preguntar por:
 - Antecedentes de TCE
 - Forma de instauración (si aguda, si bilateral).
 - Tiempo de evolución.
 - Antecedentes de infección.
 - Episodios similares.
- **Exploración física:**
 - General: constantes básicas. Exploración otorrinolaringológica básica (valorar oído, nariz y garganta) y otoscopia.
 - Neurológica: Debemos valorar los distintos músculos inervados por el nervio facial buscando posibles asimetrías.
 - Alteraciones propias de la afectación del VIII par craneal:
 - MOTORAS: asimetría facial, hemicara inexpresiva con desaparición de pliegues

frontales y nasogenianos homolaterales, signo de Bell, desviación de la comisura labial hacia el lado sano.

- SENSITIVAS: molestias oculares con alteraciones de la secreción lacrimal, parestesias en cara, algeusia, otalgia, algiacusia. El dolor no está relacionado con el grado de severidad de la parálisis.
- **Pruebas complementarias:**
 - Hemograma.
 - Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, amilasa, PCR.
 - Coagulación básica.
 - TAC craneal: si sospecha de parálisis facial no idiopática o patología neurológica acompañante.

TRATAMIENTO

- **Cuidados oculares** (lagrimas artificiales para evitar sequedad de córnea, parches oculares nocturnos).
- Evitar en la fase aguda ejercicios que impliquen musculatura facial (ej: comer chicles) ya que pueden provocar una mayor asimetría al igual que facilita la aparición de sincinesias.
- **Prednisona a 1mg/Kg/día** hasta un máximo de 60-80mg durante una semana y posterior disminuir gradualmente durante otra semana. Dentro en las primeras 48h después del inicio, presentan mejor recuperación más rápida y más completa.
- Si sospecha de infección por herpes:
 - **Aciclovir 200 mg** 1 cada 4 horas durante 5 días vía oral o
 - **Fanciclovir 500mg** 1 cada 8 horas durante 7 días vía oral o
 - **Valaciclovir 1 gr** 1 cada 8 horas durante 7 a 10 días vía oral.
- Suele tener una evolución clínica favorable y se resuelve ad integrum y sin necesidad de tratamiento en un 70% de los casos. El 30% restante podrá tener secuelas leves o graves.

BIBLIOGRAFÍA

- Bernard C. Kinesiterapia de las parálisis faciales. EMC-Kinesiterapia- Medicina física 2013; 34 (4): 1-11. [Artículo E-26-463-B-10].
- Balaguer García R, Casaña Pérez S., Suárez-Varela M.M, Escudero Torella M., Dalmau Galofre J. Secuelas de las parálisis faciales periféricas. Acta otorrinolaringológica española, 2010; 61 (2): 89-93.
- Teixeira L.J, Valbuza J.S, Physical therapy for Bell's palsy. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2008; (12; Art N. O CD006283).
- Sullivan, F. M, Swan I.R, Donnan P.T, Morrison J.M, Smith B. H, Mckinstry B, et al. Early treatment with prednisolone or acyclovir in Bell's palsy. N Engl J Med, 2007; 357: 1598-1607.